

Articulation de la hanche (Articulation coxo-fémorale)

PLAN :

1. Introduction
2. Anatomie descriptive
 - 2.1. Surfaces articulaires
 - 2.1.1. Tête fémorale
 - 2.1.2. Acétabulum
 - 2.1.3. Labrum acétabulaire
 - 2.2. Moyens d'unions
 - 2.2.1. Capsule
 - 2.2.2. Ligaments passifs
 - 2.2.3. Ligaments actifs
 - 2.3. Moyen de glissement
3. Anatomie fonctionnelle
4. Anatomie clinique

Les objectifs :

Connaitre les surfaces articulaires.

Connaitre les moyens d'unions.

Connaitre les mouvements de l'articulation.

1. Introduction :

L'articulation coxo-fémorale est une articulation proximale du membre pelvien qui unit l'os coxal au fémur. C'est une diarthrose de type sphéroïde (énarthrose), a trois degrés de liberté.

C'est une articulation profonde stable et mobile, elle est adaptée à la position debout et à la nécessité pour l'homme de marcher.

2. Anatomie descriptive

2.1. Surfaces articulaires

- 2.1.1. Tête fémorale : 2/3 d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon, située à la partie supéro-médiale de l'extrémité proximale du fémur. Elle est orientée en haut, en avant et en dedans.
La tête fémorale est encroutée de cartilage il existe cependant une zone rugueuse dépourvue de cartilage à la partie postéro-inférieure de la tête : la fovéa capitis.
- 2.1.2. Acétabulum : situé à la partie moyenne de la face latérale de l'os coxal, limité dans son pourtour par limbus. Il est orienté en bas, en dehors et en avant. Il présente deux parties :
*Périphérique : la surface semi lunaire, articulaire encroutée de cartilage.
*Centrale : la fosse acétabulaire, non articulaire.
- 2.1.3. Labrum acétabulaire ou bourrelet cotyloïdien : c'est un fibro-cartilage annulaire, qui s'insère sur le limbus, avec une face axiale encroûtée de cartilage hyalin, il augmente la surface et la profondeur de l'acétabulum.
NB/Le labrum acétabulaire passe en pont au-dessus de l'incisure ischio-pubienne formant le ligament transverse de l'acétabulum.

2.2. Moyens d'unions

- 2.2.1. Capsule : Manchon fibreux cylindrique qui s'insère sur la face périphérique du labrum, le bord inférieur du ligament transverse, le long de la ligne intertrochantérique du fémur en avant et à la partie moyenne de la face dorsale du col fémoral.
NB : Elle présente une zone renforcée : les fibres orbiculaires (circulaires) qui accentuent la rétention de la tête fémorale et des freins capsulaires véritables replis inférieurs.
- 2.2.2. Ligaments passifs :
- Le ligament ilio-fémoral ou ligament de Bertin : de forme triangulaire, composé de deux faisceaux s'élargissant en éventail et passant en avant de la tête fémorale.

*Faisceau supérieur : Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure ; de trajet horizontal, il se termine sur le tubercule supérieur de la ligne intertrochantérique.

*Faisceau inférieur : Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure ; de trajet oblique, il se termine sur le tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique.

- Le ligament pubo-fémoral : Il prend naissance sur l'éminence ilio-pectinée du pubis, de trajet oblique en bas et en dehors, pour se terminer à la partie toute inférieure de la ligne intertrochantérique.
- Le ligament ischio-fémoral : Il est postérieur, il naît de la tubérosité ischiatique, pour se terminer sur le grand trochanter et sur la zone orbiculaire de la capsule.
- Le ligament de la tête fémorale ou ligament rond : Il est intra-capsulaire et extra-synoviale.

Il prend origine sur la fovéa capitis de la tête fémorale et se termine par trois faisceaux ; antérieur, et postérieur en arrière des cornes antérieure et postérieure de la surface semi lunaire et le faisceau moyen sur le ligament transverse de l'acétabulum.

Il est Centré par une artère qui irrigue la tête fémorale, il est aussi un lubrificateur articulaire, et il n'a aucun rôle dans la solidité articulaire.

2.2.3. Ligaments actifs :

Le muscle quadriceps et ilio-psoas en avant.

Les muscles glutéaux et pévi-trochantériens en arrière et en dehors.

Les muscles adducteurs en dedans.

2.3. Moyen de glissement : La membrane synoviale tapisse la face profonde de la capsule.

Elle secrète le liquide synovial ou synovie qui lubrifie et nourrit le cartilage articulaire.

3. Anatomie fonctionnelle :

3.1. Dans le plan sagittal autour d'un axe horizontal :

- Mouvement de flexion : mouvement qui porte la cuisse en avant et qui rapproche la face ventrale de la cuisse à celle du tronc avec une amplitude de 80-90° (Position debout – Décubitus dorsal), genou fléchi : 120°.
- Mouvement d'extension : mouvement dans qui porte la cuisse en arrière et qui éloigne la face ventrale de la cuisse de celle du tronc avec une amplitudes de 10- 20°.
Genou fléchi : 0-10°.

3.2. Dans le plan frontal autour d'un axe antéro-postérieur :

- Mouvements d'abduction : mouvement qui éloigne la cuisse du plan sagittal du corps, avec une amplitude de 45° variable selon l'âge et les personnes, elle peut arriver jusqu'à 90°.
- Mouvements d'adduction : mouvement qui rapproche la cuisse du plan sagittal du corps
L'adduction pure est impossible du fait du contact des deux membres pelviens dans la position de référence.
Le mouvement est uniquement possible s'il est associé à une flexion, qui permet le croisement des cuisses avec une amplitude de 30°.

3.3. Dans le plan horizontal autour d'un axe vertical :

- Mouvement de rotation latérale : faisant tourner la pointe du pied à l'extérieur, avec une amplitude de 35°.
- Mouvement de rotation médiale : faisant tourner la pointe du pied à l'intérieur, avec une amplitude de 15°.

- ❖ Mouvements de Circumduction : ces différents mouvements élémentaires peuvent être combinés, aboutissant au mouvement de circumduction.

4. Anatomie clinique

Articulation fréquemment atteinte par l'arthrose : coxarthrose.

Accident de tableau de bord : tête du fémur rentre dans l'acétabulum.

Luxation avec risque de rupture du ligament de la tête fémorale provoquant la nécrose de celle -ci

Luxation congénitale : on lunge le bébé en abduction forcée.

Arthrite : inflammation : souvent infection grave.

Fractures du col du fémur chez les personnes âgées et risque de nécrose de la tête fémorale.

Références :

Rouviere H. *Anatomie Humaine Descriptive , Topographique et Fonctionnelle. Tome3. Membres.ed.masson 2002.*

Hmmoudi SS. *Le cours d'anatomie.fasc.2 appareil locomoteur..membre inférieur.ISBN 2008*



